

Surveillance épidémiologique de la coqueluche

Bordetella pertussis- 2025

26 mai 2026

Auteurs: I. Peeters¹ • A. Litzroth¹ • I. Desombere² • H. Martini³ • E. Van Honacker³
Révision: C. Boulouffe⁴ • P. Carrillo⁵ • F. Rolin⁶ • N. Hammami⁷

¹Epidémiologie des maladies infectieuses, Sciensano; ²Centre national de référence pour *Bordetella pertussis* (partenaire UZ Brussel), Sciensano; ³Centre national de référence pour *Bordetella pertussis*, UZ Brussel; ⁴Agence pour une Vie de Qualité; ⁵Office de la Naissance et de l'Enfance; ⁶Vivalis; ⁷Department Zorg

Messages clés

Forte baisse des cas de coqueluche en 2025

En 2025, le CNR a rapporté 202 cas de coqueluche, une baisse significative par rapport aux pics des années épidémiques 2023 (1048 cas) et 2024 (3404 cas).

Les nourrissons de moins d'un an restent le groupe à risque le plus important

Bien que les nourrissons de moins d'un an ne représentent que 15% des cas signalés (64/427), ils concernent presque 50% des hospitalisations (18/37) selon les données de la déclaration obligatoire.

Une amélioration de la couverture vaccinale maternelle pour la coqueluche reste indispensable

En raison du nombre élevé d'hospitalisations chez les jeunes nourrissons, dont un tiers avant l'âge où débute la vaccination de base, il reste essentiel de miser sur la vaccination maternelle. Malgré la recommandation émise par le Conseil Supérieur de la Santé depuis 2013 et la mise à disposition gratuite du vaccin, il existe encore des différences régionales considérables en ce qui concerne la couverture vaccinale.

Une enquête menée en 2025 auprès de médecins généralistes et de gynécologues a mis en évidence plusieurs obstacles à la recommandation de la vaccination maternelle contre la coqueluche, notamment des barrières linguistiques, le manque de temps lors des consultations et la perception d'une responsabilité partagée entre les professionnels de santé. Dans la communauté francophone, un accès limité au vaccin gratuit a été rapporté.

TABLE DES MATIERES

1. Description de la surveillance	4
1.1. Sources de données	4
1.2. Définition de cas	4
<i>Critères de laboratoire</i>	5
<i>Critères épidémiologiques</i>	5
<i>Classification des cas</i>	5
1.3. Représentativité des données	5
2. Résultats	6
2.1. Tendances par année et par région	6
2.2. Tendances par groupe d'âge	7
2.2.1. Tous les âges	7
2.2.2. Nourrissons de moins d'un an	8
2.3. Hospitalisation et statut vaccinal	8
2.3.1. Hospitalisations	9
2.3.2. Statut vaccinal	9
2.4. Taux de mortalité	10
3. Importance pour la santé publique	10
4. Plus d'informations	11
5. Annexes	12

1. Description de la surveillance

La surveillance de la coqueluche¹ en Belgique se base sur des données provenant de différentes sources, qui sont abordées d'une manière intégrée dans le présent rapport.

1.1. Sources de données

- Centre national de référence (CNR) pour *Bordetella pertussis* : Il s'agit d'un consortium regroupant l'UZ Brussel et Sciensano, dans le cadre duquel l'UZ Brussel réalise les PCR, les cultures, la confirmation et le typage des souches, alors que Sciensano réalise la détermination d'anticorps IgG anti-toxine pertussique.
- Déclaration obligatoire : La coqueluche est une maladie à déclaration obligatoire en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles.
- Réseau de laboratoires vigies (Epilabo) : Il s'agit d'un réseau de laboratoires vigies participant volontairement à la collecte de données. Ce réseau est organisé par Sciensano, et transmet tant les résultats sérologiques positifs que les résultats PCR positifs de cas de *B. pertussis*.
- Réseau des médecins généralistes et pédiatres, Pedisurv : Depuis juin 2022, les cas graves de coqueluche chez les enfants de moins de 3 ans, qui sont hospitalisés, ont été ajoutés à la surveillance (vous trouverez ici les critères d'inclusion). Les médecins participants reçoivent tous les mois une invitation leur demandant d'enregistrer les cas éventuels. Si aucun cas ne s'est présenté, il est demandé au médecin de le confirmer en envoyant une 'notification zéro'.
- Résumé Hospitalier Minimum (RHM) : Tous les hôpitaux non psychiatriques de Belgique sont tenus de contribuer à l'enregistrement anonyme de données administratives, médicales et infirmières de toutes les admissions à l'hôpital. Les maladies sont codées depuis 2015 selon la "Classification internationale des maladies", version 10e (ICD-10-CM). Les données sont disponibles avec un retard d'environ deux ans. Voir annexe 1 pour plus d'informations.
- Taux de mortalité : Statbel collecte et centralise les informations relatives au taux de mortalité, enregistrées via les actes de décès, par les Communautés française et flamande. Ces informations sont disponibles via l'application web SPMA. Depuis 1998, l'ICD-10-CM est utilisée pour coder les causes de décès. Les codes « A37.0 » (Coqueluche par *B. pertussis*) et « A37.9 » (Coqueluche, pathogène non spécifié) sont utilisés. Les données sont disponibles avec un retard d'environ trois ans.

1.2. Définition de cas

Source: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Critères cliniques

Toute personne atteinte de toux persistante depuis au moins deux semaines ET présentant au moins un des trois symptômes suivants :

- toux paroxystique (quintes de toux) ;
- sifflement inspiratoire (chant du coq) ;
- vomissements post-toussifs.

OU

Toute personne chez qui un médecin a diagnostiqué la coqueluche

¹ Vous trouverez des rapports récents et plus d'informations sur la coqueluche sur notre site web sous le sujet de santé 'Coqueluche'.

OU

Tout nourrisson de moins d'1 an présentant des épisodes d'apnée

Critères de laboratoire

Au moins un des trois critères suivants :

- isolement de *B. pertussis* à partir d'un échantillon clinique ;
- détection par PCR de *B. pertussis* sur un échantillon clinique ;
- réaction immunitaire par formation d'anticorps spécifiques dirigés contre *B. pertussis*, en tenant compte du statut vaccinal.

Critères épidémiologiques

Lien épidémiologique de transmission de personne à personne

Classification des cas

- Cas possible : patient répondant aux critères cliniques
- Cas probable : patient répondant aux critères cliniques et épidémiologiques
- Cas confirmé : patient répondant aux critères cliniques et aux critères de laboratoire

1.3. Représentativité des données

Le tableau clinique de la coqueluche est variable et un test n'est pas systématiquement effectué pour chaque cas. Aucun des réseaux de surveillance pour la coqueluche n'est exhaustif. Ils ne permettent donc pas de déterminer le nombre exact de cas de coqueluche en Belgique mais ils ont pour but de suivre les tendances épidémiologiques.

Pour les données du CNR, nous observons comme prévu depuis le début du remboursement des PCR en 2019 une baisse du nombre de PCR réalisées par le CNR par rapport au nombre total de PCR remboursées (2019: 64%, 2023: 30%). L'exhaustivité des données du CNR pour les cas confirmés a donc probablement baissé. Plusieurs laboratoires effectuent des tests multiplex (un test combiné via lequel plusieurs germes respiratoires sont détectés en une fois), ce qui peut également avoir pour conséquence que la part du CNR est plus réduite.

Le système de surveillance Epilabo est basé sur une participation volontaire des laboratoires. En 2025, 36 laboratoires ont participé (contre 37 en 2024), principalement en Flandre. Des nombres absolus ne peuvent donc pas facilement être comparés entre les régions. Si nous limitons les analyses aux seuls laboratoires ayant continuellement fait le rapportage au cours de toute la période, nous observons les mêmes tendances que dans les analyses incluant tous les laboratoires.

Le réseau Pedisurv a une portée dans toute la Belgique avec la participation de 219 pédiatres (Belgique) et médecins généralistes (Bruxelles) en 2025. On estime à 52% la couverture des hospitalisations pédiatriques par les hôpitaux participant au réseau.

En Flandre, l'obligation de déclaration comprend les cas possibles (avec des critères de laboratoire probables), les cas probables et les cas confirmés. À Bruxelles et en Wallonie, l'obligation de déclaration est limitée aux cas confirmés. En outre, en Wallonie, entre 2020 et novembre 2023, seuls les cas concernant des enfants de moins de 3 ans étaient soumis à une obligation de déclaration.

En ce qui concerne le Résumé hospitalier minimum, Il faut tenir compte du fait que ces données n'étaient au départ pas collectées à des fins épidémiologiques et que le diagnostic et la codification des maladies peuvent varier d'un hôpital à l'autre.

2. Résultats

2.1. Tendances par année et par région

Le nombre annuel de cas de coqueluche est représenté à la Figure 1. Après la circulation en hausse des cas de coqueluche entre août 2023 et septembre 2024 inclus, le nombre de cas rapporté par le CNR est resté faible en 2025, avec 202 cas contre 1048 en 2023 et 3404 en 2024.

En 2025, 107 des 202 échantillons CNR confirmés venaient de Flandre (53%), 37 de Wallonie (18%) et 58 de Bruxelles (29%). Il s'agissait de 141 PCR (69%), de 59 analyses sérologiques (29%) et de 2 analyses combinées (1%).

Sur les 427 cas de coqueluche à déclaration obligatoire en 2025, 302 cas (71%) ont été signalés en Flandre (dont 274 confirmés et 28 probables), 64 cas confirmés (15%) en Wallonie et 58 cas confirmés (14%) à Bruxelles.

L'incidence rapportée dans le cadre de la déclaration obligatoire en 2025 en Belgique s'élève à 3,6 pour 100 000 personnes, mais elle varie en fonction de la province et de la source de données (Figure 2).

Figure 1: Nombre de cas de coqueluche par source de données, Belgique, 2010-2025
(Sources : laboratoires vigies, déclaration obligatoire, Centre national de référence pour *Bordetella pertussis*)

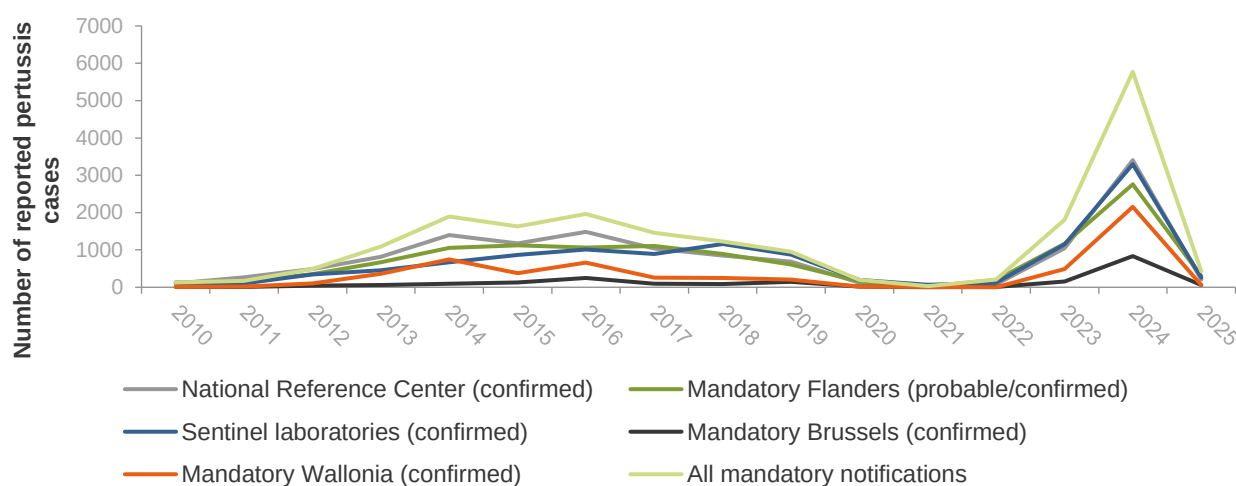
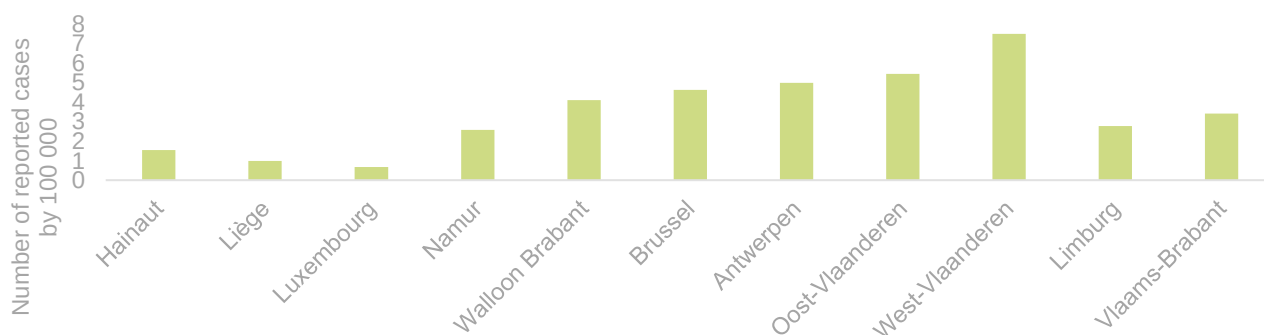


Figure 2: Nombre de cas de coqueluche en 2025 pour 100.000 habitants par province (Sources : déclaration obligatoire, Statbel)



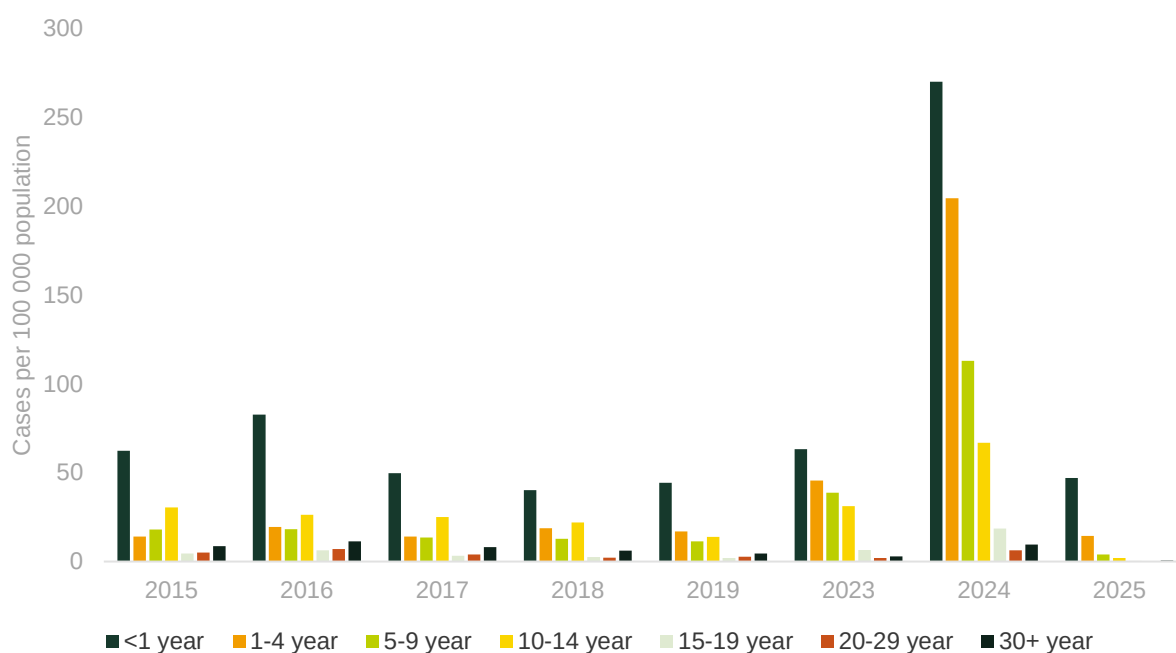
2.2. Tendances par groupe d'âge

2.2.1. Tous les âges

Selon les données du CNR, une baisse a été observée dans tous les groupes d'âge en 2025, par rapport à l'année 2024 qui a connu un pic. L'incidence la plus élevée reste observée chez les nourrissons de moins d'un an et chez les enfants de 1-4 ans (Figure 3).

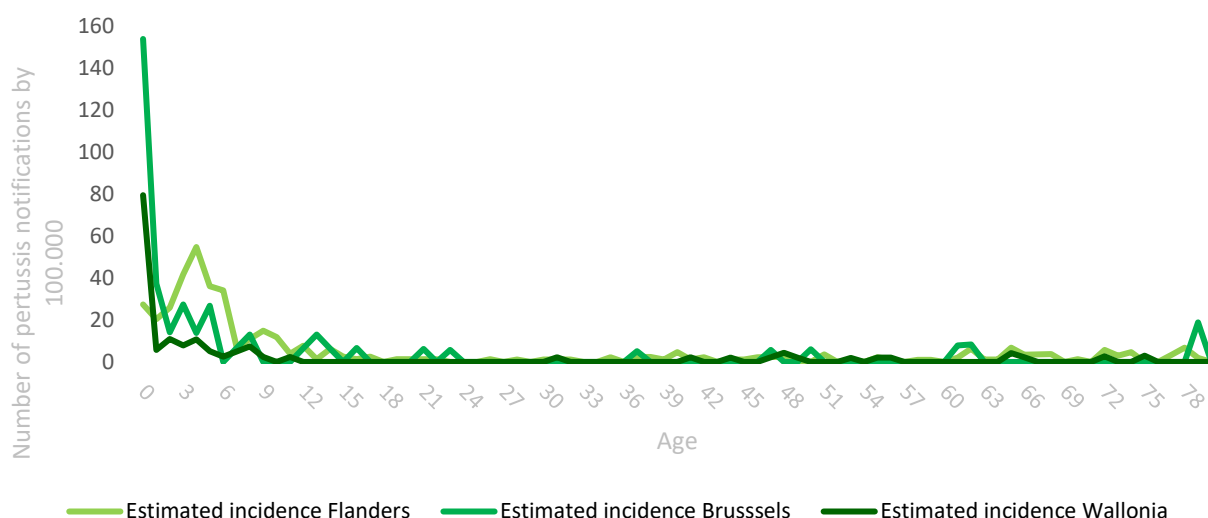
Tout comme en 2024, le pic le plus élevé dans l'incidence signalée selon la déclaration obligatoire a été observé chez les nourrissons de moins d'un an à Bruxelles et en Wallonie, mais pas en Flandre. Une explication possible pourrait résider dans des différences de couverture vaccinale maternelle (85% en Flandre; 39% en Wallonie; 31% à Bruxelles selon les chiffres de 2019), bien que d'autres facteurs, tels que les pratiques de dépistage et de déclaration, puissent également jouer un rôle (Figure 4).

Figure 3: Répartition des cas de coqueluche pour 100.000 habitants, par groupe d'âge*
(Sources : CNR, Statbel)



*Les années 2020-2022, caractérisées par des nombres peu élevés de cas de coqueluche, n'ont pas été reprises.

Figure 4: Nombre de cas de coqueluche signalés par âge en 2025, pour 100.000 habitants par an
(Sources : déclaration obligatoire, Statbel)

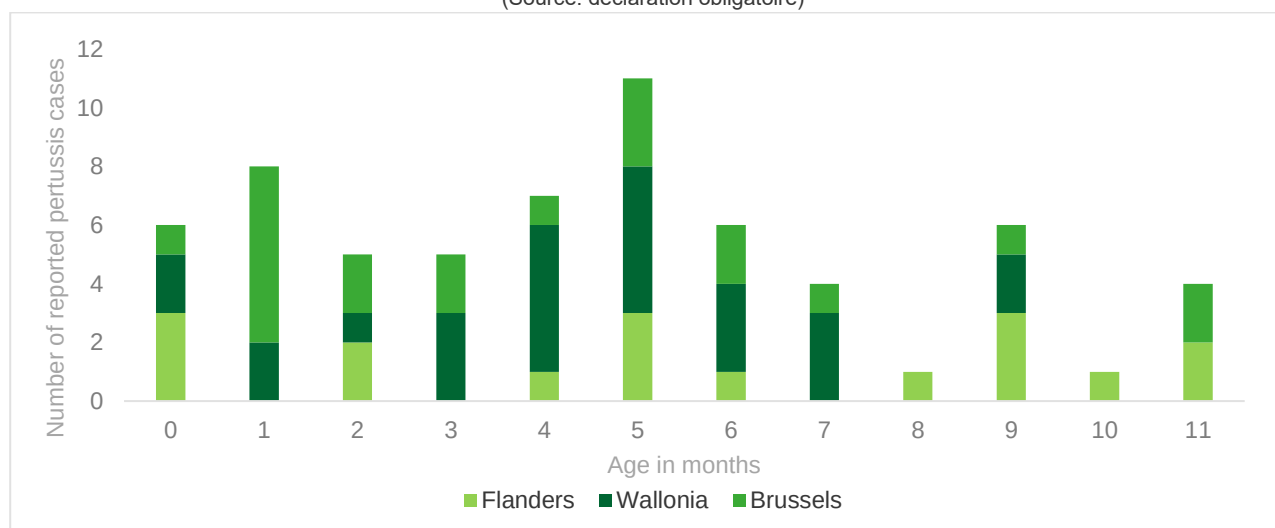


2.2.2. Nourrissons de moins d'un an

Selon les données du CNR, 51 cas sur les 202 (25%) viennent du groupe d'âge de moins d'un an. En Flandre, il s'agit de 8/107 cas (7%), en Wallonie de 18/37 cas (49%) et à Bruxelles de 25/58 cas (43%).

Selon les déclarations obligatoires, 64 cas ont été signalés chez des nourrissons de moins d'un an (dont 17 en Flandre, 26 en Wallonie et 21 à Bruxelles) (Figure 5). Deux-tiers des cas de coqueluche signalés en dessous d'un an concernaient des nouveau-nés de moins de 6 mois.

Figure 5. Nombre de cas de coqueluche signalés par région, en dessous d'un an, 2025
(Source: déclaration obligatoire)



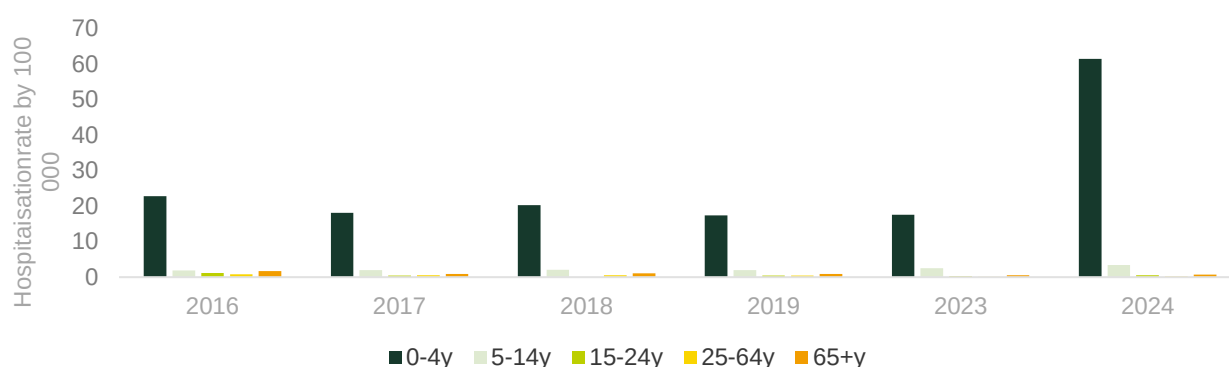
2.3. Hospitalisation et statut vaccinal

Les informations sur les hospitalisations et le statut vaccinal sont souvent incomplètes dans nos sources de données. La source la plus complète pour 2025 est la déclaration obligatoire.

2.3.1. Hospitalisations

Les informations provenant du Résumé hospitalier minimum (RHM, annexe 1) indiquent que la plupart des hospitalisations à la suite d'une coqueluche concernent des enfants de 0-4 ans. En 2024 (données disponibles les plus récentes), l'épidémie de coqueluche a clairement entraîné une forte augmentation des hospitalisations dans ce groupe d'âge le plus touché. Parmi les hospitalisations des enfants de 0-4 ans, 78 % concernaient des nourrissons de moins d'un an (Figure 6).

Figure 6. Pourcentage d'hospitalisations pour une coqueluche, par groupe d'âge
(Source : Résumé hospitalier minimum, Statbel)



* Les années 2020-2022, caractérisées par des nombres peu élevés de cas de coqueluche, n'ont pas été reprises.

Via la déclaration obligatoire, la Flandre comptait 27 hospitalisations en 2025 (9% des cas signalés, dans 39% des cas les informations manquaient). La Wallonie comptait neuf hospitalisations en 2025 (14% des cas signalés, les informations étaient complètes). Bruxelles comptait une hospitalisation en 2025 (2% de cas signalés, dans 53% des cas les informations manquaient).

En Flandre, neuf des 27 hospitalisations concernaient des nourrissons de moins d'un an; en Wallonie, cela concernait huit des neuf hospitalisations. Et à Bruxelles, il s'agissait de la seule hospitalisation signalée. Un tiers de ces hospitalisations chez les nourrissons de moins d'un an a lieu à un âge précédant le début de la vaccination.

Dans PediSurv, cinq cas ont été enregistrés en 2025, dont trois cas en Flandre et deux en Wallonie. La durée moyenne d'hospitalisation était de deux jours (intervalle 1-5 jours). Aucun des cas n'avait de comorbidité sous-jacente. Aucun patient n'a été admis aux soins intensifs.

2.3.2. Statut vaccinal

Les données sur le statut vaccinal étaient disponibles via la déclaration obligatoire pour 60% des cas en Flandre, pour 55% des cas en Wallonie et pour 30% des cas à Bruxelles.

Le Tableau 1 reprend le statut vaccinal combiné aux données hospitalières pour les enfants de moins d'un an par région. Les hospitalisations concernaient principalement le groupe 'trop jeunes pour être vaccinés' (6/14) et le groupe 'non vaccinés selon le schéma' (5/7), bien que l'interprétation soit compliquée par le nombre limité de cas et l'absence d'informations pour une proportion importante des cas.

Tableau 1. Statut vaccinal de tous les cas de coqueluche signalés de moins d'un an, par région, 2025 (Source: déclaration obligatoire)

Région	Statut vaccinal	n	Statut d'hospitalisation		
			Oui	Non	Inconnu
Flandre	Trop jeunes pour être vaccinés	3	2	0	1
	Vaccinés selon le schéma	9	4	4	1
	Non vaccinés selon le schéma	3	2	0	1
	Information manquante	2	1	1	0
	Total	17	9	5	3
Wallonie	Trop jeunes pour être vaccinés	4	3	2	0
	Vaccinés selon le schéma	16	2	14	0
	Non vaccinés selon le schéma	3	3	0	0
	Information manquante	3	0	3	0
	Total	26	8	19	0
Bruxelles	Trop jeunes pour être vaccinés	7	1	0	6
	Vaccinés selon le schéma	4	0	4	0
	Non vaccinés selon le schéma	1	0	1	0
	Information manquante	9	0	3	6
	Total	21	1	8	12

Des informations sur la vaccination maternelle n'étaient disponibles qu'en Flandre. Celle-ci avait été effectuée correctement chez cinq des neuf mères de cas de coqueluche de moins de six mois, dont trois avaient été hospitalisés. Une des neuf mères n'était pas vaccinée, cet enfant a été hospitalisé et chez les trois autres cas, l'information était manquante (tous les trois cas avaient été hospitalisés).

2.4. Taux de mortalité

Un décès d'une personne de plus de 80 ans en Flandre a été signalé en 2025 dans le cadre de la déclaration obligatoire, comme un cas probable de coqueluche. Des informations provenant des actes de décès (pour plus d'informations, voir l'[annexe 2](#)) entre 2010 et 2023 (informations les plus récentes), nous apprennent que 13 personnes sont décédées par suite de la coqueluche (ICD-10 A37.0 et A37.9). Il s'agissait du décès de sept enfants de moins d'un an (dont deux ont eu lieu en 2023).

3. Importance pour la santé publique

Après l'épidémie de coqueluche en 2023-2024, une baisse évidente du nombre de cas de coqueluche rapportés a été observée en 2025, conformément au caractère cyclique bien connu de la coqueluche. Malgré cette baisse, l'incidence est restée élevée chez des nourrissons de moins d'un an, principalement en Wallonie et à Bruxelles. Ce groupe présente un risque accru de maladie grave et d'hospitalisation. De plus, un tiers des hospitalisations a lieu avant le début de la vaccination de base (à l'âge de huit semaines).

Avant le début de la vaccination de base à huit semaines (couverture vaccinale 3^e dose DTP de 97,5% selon les données de 2019), les nourrissons les plus jeunes peuvent seulement être protégés indirectement via la vaccination de la femme enceinte lors de chaque grossesse. La vaccination maternelle a une efficacité élevée (jusque 97% de protection contre la mortalité des nouveau-nés²). Bien que cette vaccination soit recommandée depuis 2013 et disponible gratuitement dans toutes les entités fédérées, des différences

² Amirthalingam G, Campbell H, Ribeiro S, Stowe J, Tessier E, Litt D, et al. Optimization of Timing of Maternal Pertussis Immunization From 6 Years of Postimplementation Surveillance Data in England. Clin Infect Dis. 2023 Feb 1;76(3):e1129–39.

régionales considérables existaient encore en 2020 en matière de couverture vaccinale (85% en Flandre, 39% en Wallonie et 31% à Bruxelles).

Une étude réalisée fin 2025 auprès de généralistes et de gynécologues a répertorié différents obstacles pour la recommandation de la vaccination maternelle contre la coqueluche. Dans toutes les régions, ce sont principalement les barrières linguistiques, le manque de temps pendant les consultations et la supposition qu'un autre professionnel de santé parlera de la vaccination qui ont été avancés comme obstacles principaux. Par ailleurs, l'accès à un vaccin gratuit s'est avéré limité en Communauté française. En collaboration avec les entités fédérées compétentes et les associations professionnelles, des actions d'amélioration vont être mises en place, dont une communication ciblée sur le matériel d'information multilingue disponible au niveau régional et les actuelles modalités de remboursement.

Etant donné que l'immunité après la vaccination ou la maladie ne dure pas la vie entière et que les adultes peuvent être asymptomatiques ou légèrement symptomatiques en cas d'infection par *B. pertussis*, mais qu'ils peuvent constituer une source d'infection pour les jeunes enfants vulnérables, [le Conseil supérieur de la santé conseille à tous les adultes l'administration d'une dose supplémentaire](#) du vaccin contre la coqueluche, quel que soit leur statut vaccinal. Etant donné que seulement un vaccin combiné est disponible (diphtérie-tétanos-coqueluche) et que [le Conseil supérieur de la santé recommande de vacciner les adultes contre le tétanos](#), cela revient à répéter la dose tous les 10 ans. La coqueluche est une maladie à déclaration obligatoire afin que, si nécessaire, une chimioprophylaxie puisse être commencée à temps pour protéger les membres vulnérables de la famille.

4. Plus d'informations

- Informations détaillées sur la coqueluche dans le cadre de la déclaration obligatoire:
https://www.aviq.be/sites/default/files/documents_pro/2024-03/Fiche-Coqueluche.pdf
- Avis du Conseil supérieur de la santé sur la vaccination contre la coqueluche :
 - Adultes:
<https://www.hgr-css.be/file/download/a74babd7-f754-492f-bc1c-59ea871261e5/Ry9vTaIBH7bwxAziKVQbyiQVgZpeuO3dILPM2WX4cy83d.pdf>
 - Enfants:
<https://www.hgr-css.be/file/download/7818bb0d-0842-4a3d-bfc7-b373a4e2c501/LUxtpKj5dNQRJXmq2zLxBZbSJaOiHgehBrfnupPbE3d.pdf>
 - Vaccination pendant la grossesse:
<https://www.hgr-css.be/file/download/881044e8-b658-44c2-ba2a-0a6de48cdd6b/a4RnokhRiePu3WfwzQZw7uADpcMIEdvpBX4Oxztukl3d.pdf>

Vous soupçonnez un cas de **COQUELUCHE** ?

Flandre: [Cliquez ici](#)

Bruxelles: [Cliquez ici](#)

Wallonie : [Cliquez ici](#)

5. Annexes

Annexe 1: Données d'hospitalisations

Le nombre d'hospitalisations en lien avec la coqueluche a été obtenu à l'aide de données provenant du Résumé Hospitalier Minimum (RHM), système d'enregistrement de données administratives, médicales et infirmières sur toutes les admissions à l'hôpital, auquel tous les hôpitaux non psychiatriques de Belgique sont tenus de contribuer. Les maladies sont codées depuis 2015 selon la "Classification internationale des maladies", version 10e (ICD-10-CM).

Les séjours à l'hôpital suivants ont été pris en compte : hospitalisation conventionnelle et hospitalisation de jour non chirurgicale. Les diagnostics principaux³ ont été utilisés.

Les codes suivants ont été utilisés : A37 Coqueluche.

Annexe 2: Données de mortalité via l'acte de décès

Statbel centralise les données de mortalité, enregistrées via les actes de décès, par les Communautés française et flamande. Ces informations sont disponibles via l'application SPMA. Depuis 1998, l'"International Classification of Diseases", 10e version (ICD-10-CM) est utilisée pour coder les causes de décès. Les codes ICD-10-CM « A37.0 » (Coqueluche par *B. pertussis*) et « A37.9 » (Coqueluche, pathogène non spécifié) sont utilisés. Pour le présent rapport, des données entre 2010 et 2023 ont été analysées.

³ Le diagnostic principal est "l'affection qui à l'examen s'avère être la cause principale de l'hospitalisation du patient dans la spécialisation".

CONTACT

Ilse Peeters • ilse.peeters@sciensano.be

À PROPOS DE SCIENSANO

Sciensano est un institut scientifique public et indépendant qui œuvre pour la santé des personnes, des animaux et de leur environnement.

Nous menons des recherches scientifiques et des activités de surveillance, et apportons notre soutien aux pouvoirs publics ainsi qu'à diverses agences et organisations en leur fournissant expertise, conseils et services dans le domaine de la santé.

Sciensano accorde une grande importance au principe « One Health », qui souligne que la santé des personnes, des animaux et de leur environnement sont étroitement liées. C'est pourquoi nos recherches sont interdisciplinaires et intègrent différentes perspectives.

Avec plus d'un millier de collaborateurs et 120 ans d'expertise scientifique, Sciensano est un institut scientifique de renom, qui fait partie de divers réseaux scientifiques internationaux.

PLUS D'INFOS

Sciensano.be – info@sciensano.be

14 rue Juliette Wytsman • Bruxelles • Belgique • T + 32 2 642 51 11